

קווים מנחים לאבחון וטיפול בזיהומים שכיחים בקהילה במבוגרים | 2023

כתיבה: ד״ר דמיטרי ביילין | ייעוץ מקצועי: ד״ר ענבל פוקס

⁽¹⁾ כל הכתוב לעיל מיועד לשימוש סגל רפואי בלבד. ההמלצות מבוססות על הנחיות קליניות עדכניות, ומהוות כלי עזר בלבד- אין הוא מהווה תחליף לשיקול דעת קליני

בקטראוריה אסימפטומטית

לא מצריך טיפול, פרט למקרים הבאים:

- הריון
- במטופל לפני/אחרי פרוצדורה ניתוחית בדרכי השתן, תיתכן הופעה של חיידק בעל עמידויות רבות MDR (טיפול על פי רגישות ובייעוץ ימ"ז)

דלקת בשלפוחית השתן | CYSTITIS

נשים ♀:

סטיק שתן- תשובה שלילית מקטינה סיכוי של דלקת בשתן, יש לחשוב על DD אחר. בחלק מהמקרים ניתן לטפל אמפירית.

תרבית שתן – בד"כ לא נדרשת פרט למקרים הבאים: הריון; מחלות רקע לרבות דיכוי חיסוני; סוכרת; בעיות בדרכי שתן; מחלת כליות; צעירות עם מאורע 2 ומעלה באותה שנה/ **כל** טיפול Abx ב-3 חודשים אחרונים. **הדרכה ע"י אחות לנטיילת שתן MSU טיפול אמפירי לאירוע ראשון ושני בשנה החולפת:**

100 mg X 4/d Nitrofurantoin למשך 5 ימים.

בהתוויות נגד/לפי שיקול דעת רפואי:

- 3 gr X 1/d Fosfomycin מנה חד פעמית
- 2/d 960 mg X Trimethoprim Sulpha למשך 3-5 ימים
- 2/d 250 mg X Cefuroxime למשך 5-7 ימים

אין צורך לחזור על תרבית שתן בגמר הטיפול (פרט להריון).

גברים ♂: (ציסטיטיס מאוד נדיר - ⁽¹⁾ **לחשוב על פרוסטיטיס / STD**)

סטיק שתן- תשובה שלילית מקטינה סיכוי של דלקת בשתן, יש לחשוב על DD אחר, יש לקחת תרבית שתן . בהופעת סימני פרוסטיטיס יש לקחת **תרבית זרע**.

טיפול אמפירי:

2/d 500 mg X Ciprofloxacin עד תשובות תרבית ואז לפי רגישויות

בהתוויות נגד/ אלרגיה:

- יש לפנות לייעוץ ימ"ז

דלקת בשופכה | URETHRITIS

לבצע שתן לכללית, אם אפשר – לשלוח תרבית מהפרשה, **לשלוח לפאנל מחלות מין**.

טיפול Abx אמפירי לפני תשובות:

- 500 mg (once) IM Ceftriaxone

וגם

- 1000 mg (once) Azithromycin או 100 mg X2/d Doxycycline למשך 7 ימים

⁽¹⁾ אם זוהה ***M.Genitalium*** הטיפול הוא ב 400 mg X1/d Moxifloxacin למשך 7 ימים

דלקת בדרכי שתן עליונות | PYELONEPHRITIS

יש לקחת שתן לכללית + תרבית.

טיפול PO אמפירי עד קבלת תשובת תרבית שתן:

2/d 750-500 mg X Ciprofloxacin

טיפול IV אמפירי כתחליף לאשפוז עד לקבלת תשובות תרבית שתן:

- 1 d 5 mg/kg X1/IV Gentamicin (בהתאם eGFR)
- 2 gr X1/d IM/IV Ceftriaxone

המשך טיפול PO בהתאם לתרבית שתן:

- 2/d 750-500 mg X Ciprofloxacin למשך 7 ימים
- 2/d 200 mg X Ofloxacin למשך 7 ימים
- 2/d 960 mg X Trimethoprim Sulpha למשך 7-14 ימים
- 2/d 500 mg X Cefuroxime למשך 14-7 ימים

אין צורך לחזור על תרבית שתן בגמר הטיפול (פרט להריון)

זיהום עורי | ERYSIPELAS ,CELLULITIS

לא לקחת תרבית שטחית עורית מפצעים פתוחים.

- 1 gr X3/ 500 mg X4/d Cephalixin

⁽¹⁾ בהעדר תגובה לצפלוספורינים לשקול טיפול המכסה MRSA כגון:

- 2/d 960 mg X Trimethoprim Sulpha

בהתוויות נגד/ אלרגיה:

- 300 mg X4/d Clindamycin

משך הטיפול 5 ימים, אם לא משתפר ניתן להאריך ל 7

לפעמים הקליניקה מחמירה אחר ימים ראשונים של הטיפול ואחר כך נרגעת.

טיפול פרופילקטי **לאירועים חוזרים** (מעל 3-4 אירועים בשנה):

- 250 mg X2/d Penicillin VK פומי למשך מספר חודשים (בייעוץ ימ"ז)
- 250 mg X2/d Erythromycin פומי למשך מספר חודשים (בייעוץ ימ"ז)

נשיכת בעלי חיים | ANIMAL BITES

יש לשטוף את הפצע במים וסבון אנטי בקטריאלי.

יש **לדווח** למשרד הבריאות במקרים של חשד לכלבת.

⁽¹⁾ **חיסון סטנוס (אם עברו 5 שנים מהמנה האחרונה)**

טיפול Abx מניעתי (לפני התפתחות הזיהום) מומלץ ל: מדוכאי חיסון; אספלניה; מחלת כבד מתקדמת; בצקת של האיזור הנגשך; מעורבות פנים/יד/ סחוס (אוזן, אף וכו'); נשיכה עמוקה המערבת מפרק/עצם – יש לשקול הדמיה/יעוץ אורתופדי.

כ 5% מנשיכות כלב מזדהמות, לעומת 80% מנשיכות חתול

Augmentin 875 mg X2/d

בהתוויות נגד/ אלרגיה לפניצילין:

- 300 mg X4/d + 500 mg X2/d Ciprofloxacin Clindamycin

משך הטיפול: 5 ימים.

מסטיטיס | MASTITIS

במרבית המקרים רק שד אחד יהיה מעורב. סימפטומים נוספים של דלקת בשד כוללים: חום גבוה (מעל 38 מעלות), צמרמורת, כאב שרירים. אך לא מחייב.

⁽¹⁾ תמיד לשאול האם הייתה טראומה לשד או ניתוחי שד בעבר; סרטן, קוסמטי (בהגדלת שד לעיתים נצפת תגובה לכיסוי של השתל ראה ערך Red Breast Syndrome).

מבחינים בין 2 סוגים עיקריים:

דלקת לא זיהומית (חסימת צינור חלב, נפוץ בקשיים בהנקה)

דלקת חיידקית

טיפול הבחירה:

יש להקפיד על הנקה וריקון השד למרות הקושי והכאב – לפחות 8 פעמים ביום

אם אין שיפור תוך 24-12 שעות גם עם נטילת NSAID ניתן לשקול טיפול **Abx אמפירית:**

- 4/d 500-1000mg X Cephalixin
- 2/d 875 mg X Augmentin

בהתוויות נגד/ אלרגיה לצפלוספורינים:

- 2/d 500 mg X Erythromycin
- 3/d 450 mg X Clindamycin

משך הטיפול 10 ימים. מעקב קליני בגמר הטיפול. ניתן לשלוח תרבית מהחלב, אבל לא מחייב.

שיפור קליני כבר אחר 48 שעות. במידה ולא ← לשלוח ל U/S לשלילת אבצס, ניתן לקחת חלב לתרבית לשלילת MRSA.

דלקת גרון/ לוע הנגרמת ע"י סטרפטוקוק | GAS PHARINGITIS /TONSILITIS

בדיקת הבחירה לקיחת משטח גרון. אין צורך במשטח חוזר בגמר הטיפול. לפי **CENTOR**

טיפול אמפירי:

Pen Rafa VK 500 mg X2/d

בהתוויות נגד/ אלרגיה לפניצילין:

- 500 mg X2/d Cephalixin

- 150 mg X2/d Roxithromycin

- 300 mg X3/d Clindamycin

משך הטיפול 10 ימים.

דלקת ריאות | PNEUMONIA

אם יש חשד לפנאמוניה – לבצע צל"ח.

⁽¹⁾ אנמנדה מכוונת למחוללים אטיפיים: Q-FEVER / לגיונלה / כלמידה/ מיקופלזמה

טיפול הבחירה בחולים ללא מחלות רקע:

- 3/d 1000 mg X Amoxicillin למשך 5 ימים

בהתוויות נגד/ אלרגיה לפניצילין:

- 100 mg X2/d Doxycycline
- 1 day) + 250 mg X1 (2-5th day) 500 mg (1st day) Azithromycin**

טיפול הבחירה בחולים **עם מחלות רקע** (מחלת לב, כבד, ריאות, כליות, סוכרת, אלכוהליזם, ממאירות, אספלניה, דיכוי חיסוני)

משלב של:

- 875 mg X2/d Augmentin
- 1 day) + 250 mg X1 (2-5th day) 500 mg (1st day) Azithromycin**

או

- 500 mg X2/d Cefuroxime
- 1 day) + 250 mg X1 (2-5th day) 500 mg (1st day) Azithromycin

****ניתן לשלב גם** 150 mg X2/d Roxithromycin במקום מקרוליד אחר ****ניתן לשלב גם** ל 500 mg X2/d Clarithromycin במקום מקרוליד אחר **בהתוויות נגד/ אלרגיה למקרולידים:**

- תוספת של 100 mg X2/d Doxycycline למשך 5 ימים

שילוב אנטיביוטי IV (במוקד/אשפוז בית) לפי CURB 65 או PSI SCORE:

- 1-2 gr X1/d IV Ceftriaxone

וגם

- 500 mg X1/d Azithromycin

משך הטיפול 5 ימים אם יש שיפור קליני (ללא חום מעל 48 שעות, וסימנים חיוניים תקינים).

התלקחות COPD

התלקחות קלה: אין צורך בטיפול אנטיביוטי, מרחיבי סימפונות באינהלציה:

10cc (2.5mg) Ventolin + 0.9% Saline השלמה ל 10cc Aerovent 2cc (0.5mg)+

התלקחות קשה: לשקול אשפוז

התלקחות בינונית: (2) או יותר מהבאים- עליה בנפח הכיח, עליה במוגלתית הכיח, החמרה בקוצר נשימה) מחלוקת לגבי טיפול Abx בקהילה.

כמו כן לשקול טיפול Abx אם: חשד לזיהום חיידקי – חולה קשה עם חסימה חמורה של דרכי אויר; כיח מוגלתי; חוסר תגובה למרחיבי סימפונות

טיפול הבחירה:

- 875 mg X2/d Augmentin
- 2/d 500 mg X Cefuroxime
- אלרגה לפניצילין/התוויות נגד**
- 100 mg X2/d Doxycycline

ניתן להוסיף גם סטרואידים PO: 30-60 mg Prednisolone משך הטיפול 5-7 ימים (גם אנטיביוטי וגם סטרואידלי)

סינוסיטיס | SINUSITIS

לא לשלוח לצילום מערות פנים.

אין צורך בטיפול Abx בשלב ראשוני (הרוב ויראלי)

הטיפול בשלב החרירף הראשוני (מספר ימים): סטרואידים נזאליים, נוגדי גודש, שטיפות אף עם מי מלח.

מתי לשקול Abx: חום גבוה מעל 39, נזלת מוגלתית, כאב בפנים מעל 3-4 ימים, היעדר שיפור קליני אחרי טיפול סימפטומטי של 7-10 ימים; מהלך מקדים של URTI במשך מספר ימים ואחריו הופעה שניה של חום, כאבי ראש ותסמיני סינוסיטיס.

טיפול הבחירה:

- 3/d 500-1000 mg X Amoxicillin
- 2/d 875 mg X Augmentin

בהתוויות נגד/ אלרגיה לפניצילין:

- 100 mg X2/d Doxycycline
- 2/d 500 mg X Cefuroxime

משך הטיפול 5-7 ימים.



הנהלה רפואית מחוז מרכז

פטרט | FUNGAL INFECTION

פטריות שמש *P.Versicolor*:

רחצה יומית במים וסבון, יבוש ואוורור. כמו כן שילוב של:

- Daktacort Cream לבוקר 1X1/d
- Hydroagisten Cream ללילה 1X1/d
- סה"כ טיפול של 14 ימים.

פטרט מקומות גסים כמו רגליים, מפרקים:

- Nizoral לבוקר 1X1/d
- Triderm Cream ללילה 1X1/d
- סה"כ טיפול של 14 ימים.

פטרט ציפורניים:

עיקר המחוללים הם דרמטופיטים, תתכן גם קנדידה.

אם שטח/ציפורן אחת – לק:

- 1X1wkX4mo/Ciclopirox/Agispor Loceryl

אם עמוקה/הרבה ציפורניים –PO, להפנות לרופא עור.

כוויות | BURNS

כוויה דרגה 1 – נזק שטחי לאפידרמיס, כווית שמש - אלוורה, ק.לחות חולף מעצמו תוך 3-5 ימים.

כוויה בעובי חלקי - נזק עד לשכבת הדרמיס היכולה להיות שטחית יחסית עם הופעת שלפוחיות לעיתים, ועד **עמוקה** עם צבע לבן באזור הכוויה. (צבע לבן יותר = עמוק יותר)
אולי תדרש הטרייה.

כוויה דרגה 3 – כוויה Full thickness, אזור הכוויה לבן, יבש ונוקשה – עלול ליצור לחץ המקפח זרימת דם לאיבר אם סירקוליקי. כוויה זו דורשת ניתוח.

חישוב מהיר של שטח הכוויה: לפי % TBSA כש 1% שווה לכף ידו של המטופל ללא האצבעות. **המצבים הבודדים בהם נטפל בכווית במרפאה:**

כוויה שאיננה חוצה מפרקים גדולים; שאיננה היקפית; שאיננה מערבת פנים, כפות ידיים, אגן, גניטליה או כפות רגליים; היקף של פחות מ 5% בילדים מתחת לגיל 5 או מבוגרים מעל גיל 50 ; היקף של פחות מ 10%- משטח הגוף בשאר הגילאים.

במידה שמדובר בשטח גדול של כוויה יש לפנות לבית חולים כאשר הכוויה מכוסה בפדי גזה ספוגים בסליין.

טיפול מקומי בכוויה ברמת המרפאה:

כל כוויה בעובי חלקי מזכה את המטופל בזריקת **טטנוס IMOVAX** (אם עברו יותר מ 5 שנים).

שטיפה: מים זורמים פושרים וסבון אנטיסטיי. **לא לשים קרח**.

שלפוחיות: אם היענות טיפולית נמוכה - ניתן לשאוב נזול ולהשאיר את העור המת י"כתבישה ביולוגית". **אחרת** - הטריית שלפוחיות ע"י ניגובן עם פד גזה רטוב והטרייה של העור "המת" עם מספריים סטריליות ע"י רופא. רחצה במים וסבון **לפני** הנחת משחות.

- Flaminal Forte
- Silverol cream

החלפת החבישה כל 24 שעות אחרי רחצה במים, סבון וייבוש.

- טיפול אנלגטי פומי לפי הצורך

- כוויות קטנות בעובי חלקי שטחי/ כוויה בשלבי סגירה ניתן לשים Dermacombin Oint X2/d.

כוויות כימיות – שטיפה 10-15 דקות תחת זרם מים. אם נתיזם קטנים – Dermacombin, כוויה גדולה או חשד למעורבות שכבות עמוקות/ הופעת Eschar שמועג התרשמות מעומק – מיון.

במידה ויש חשש לכוויה מעורבת **עם שאיפת עשן** (שיער חרוך/שריפה במקום סגור/התחשמלות)- פניו למיון במיד' תחת ניטור ומסיכת חמצן.

מיגור חיידק הליקובקטר פילורי | HP ERADICATION

אבחנה: ע"י תבחין נשיפה אוריה/ אנטיגן בצואה.

טיפול מרובע משלב 1 –עם פניצילין: (משך הטיפול הינו 14 ימים)

- 2X2/d 500 mg X Amoxicillin
- 1X2/d 500 mg X Clarithromycin
- 2/d 500 mg X Metronidazole (Flagyl) Tinidazole (Protocide)/
- 1X2/d 40 mg X Esomeprazole (Nexium)

טיפול מרובע משלב 2 –עם ביסמוט: (משך הטיפול הינו 14 ימים)

- 1X4/d 262 mg X Kalbeten
- 1X2/d 500 mg X Metronidazole (Flagyl)/Tinidazole (Protocide)
- 1X2/d 40 mg X Esomeprazole (Nexium)
- 1X2/d 100 mg X Doxycycline
- או
- 2X4/d 250 mg X Tetracycline

* הסיכוי לחזרה של PUD היא 5% לאחר אירדיקציה מלאה, ו 50% לאחר טיפול ב PPI בלבד. יש לוודא אירדיקציה חודש לאחר סיום טיפול – **בכל המטופלים**.

יש להפסיק טיפול ב PPI שבועיים לפני הבדיקה, והפסקה של קלטבן ואנטיביוטיקה 4 שבועות לפני הבדיקה. תשובה חיובית תחת טיפול הנ"ל = חיובית, שלילית =לא אמינה.



קווים מנחים לאבחון וטיפול בזיהומים שכיחים בקהילה בילדים | 2023

כתיבה: ד״ר דמיטרי ביילין, ד״ר לי אפרת-מועלם | ייעוץ מקצועי: ד״ר אלכסנדר גורי

(!) כל הכתוב לעיל מיועד לשימוש סגל רפואי בלבד. ההמלצות מבוססות על הנחיות קליניות עדכניות, ומהוות כלי עזר בלבד. אין הוא מהווה תחליף לשיקול דעת קליני

Sexually Transmitted Diseases | מחלות מין

יש לשלוח ל- **STD** בשתן (תחילת זרם). **ובירור למחלות מין שכיחות** (HIV-Ab; HBVs-Ag)**;** HIV-Ab; HBVs-Ag; HBVc-Ab; HCV Ab, Syphilis Ab**)**
(!) **במקרים של MSM להשלים גם Ig-HAV.**
(!) **תרבית הפרשה מהשופכה** ע"י מטוש ייעודי. בחולים תסמיניים נדרש טיפול אמפירי מייד, ומכון כנגד Gonorrhea + Chlamydia (בעד 30% מהמקרים יש זיהום צולב). במידת הצורך ייעוץ ימ"ז להתאמת טיפול לאחר תשובות בדיקה.

טיפול אמפירי משולב:

- IM Ceftriaxone 500 mg X1/d , מנה חד פעמית

וגם

- Doxycycline 100 mg למשך 7 ימים
- Metronidazole 500 mg X2/d למשך 7 ימים **(חשד לטריכומונס בנשים)**

בהתוויות נגד/ אלרגיה/ צפי להיענות נמוכה:

ניתן לתת כחלופה לדוקסילין: Azithromycin 20 mg/kg (max 1 gr) ,מנה חד פעמית.

התנודות מיחסי מין למשך 7 ימים מתחילת הטיפול

המלצה למין בטוח + חיסוני HPV + HBV

דיווח למשרד הבריאות: כלמידיה, סיפיליס, גונוריה, HIV

(!) **בחדש להתעללות ופגיעה מינית בקטין– חובת דיווח לגורמים הרלוונטים**

דלקת בדרכי השתן התחתונות | Lower Urinary Tract Infections

סטיק/ שתן כללית- תשובה שלילית - שוללת דלקת בשתן, יש לחשוב על DD אחר. בחלק מהמקרים ניתן לטפל אמפירית, **ולחקיד על תרבית טרם התחלת טיפול.**

תרבית שתן – מאשרת את האבחנה. ילדים גמולים/תינוק זכר- שתן אמצע זרם (MSU); בילדים לא גמולים/ תינוקת נקבה- דגימת שתן ישירות משלפוחית השתן (צנתור שלפוחית/ אספירציה Suprapubic).

(!) **אין צורך לחזור על בדיקת שתן בגמר טיפול Abx.**

(!) **לא לשלוח תרבית שתן משקית – אינפורמטיבית רק אם שלילית.**

טיפול הבחירה:

- 1X 2/d (=1 Tab Resprim Forte) SMX-TMP 160/800mg למשך 3-5 ימים.
- בִּסְרִיפּ:** 4mg/kg/dose X2/d (max 20ml X2/d) TMP [40mg/5ml] למשך 3-5 ימים.
- Nitrofurantoin (Uvamin) 5-7 mg/kg/DAY divided into 4 doses/d (max 400 mg/d) למשך 3-5 ימים **(!)** **אסור בחסר G6PD, וב eGFR>60**
- Cephalexin 15-35mg/kg/dose X3/d (max 4 gr/d) למשך 3-5 ימים.

בהתוויות נגד/לפי שיקול דעת רפואי:

- Fosfomycin 3 gr X 1/d מנה חד פעמית (מעל גיל 12), **בדלקות חוזרות ניתן לתת 2-3 מנות בהפרש של 3 ימים בינהם.**

מתחת לגיל 12 (עדויות מוגבלות על מינון של 2 גר' מנה חד פעמים) מומלץ כקו טיפול שני ליסטיטיס מחידקים עמידים.

בקטראוריה אסימפטומטית – אינה דורשת טיפול. מחשש להתפתחות עמידויות. קיימים מצבים מיוחדים המצריכים טיפול (כגון התערבות אורולוגית פולשנית). ייעוץ ימ"ז בהתאם.

דלקת בדרכי שתן עליונות | Pyelonephritis

Febrile UTI יש להתייחס כפיאלופריטיס.

לאחר אירוע ראשון של זיהום בכליה/ 2 אירועים של זיהום שלפוחית – לבצע U/S כליות ודרכי שתן תוך חודש.

המשך הטיפול הוא PO בהתאם רגישויות.

(!) **ילדים >2 חודשים – הפניה למינן (טיפול IV).**

(!) **מעל גיל 2 חודשים – ניתן לטפל PO בקהילה (אם לא מיובש/ לא מקיא/ עירני /ללא דיכוי חיסוני/ לא נכשל בטיפול PO= סימנים שלא חלפו תוך 72 שעות')**

טיפול הבחירה אמפירי:

- 20mg/kg/dose X2/d (max 875 mg X2/d) Augmentin [400mg/5ml] ל 7-10 ימים.
- PO Cefuroxime 15mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d) למשך 7-10 ימים
- IV/IM Gentamicin 5mg/kg/dose X1/d למשך 7-10 ימים
- IV/IM Ceftriaxone 50mg/kg/dose X1/d (max 1 gr/d) למשך 7-10 ימים

בחדש לזיהום נרכש/ עמיד (צנתר קבוע, הפרעות אורומכאניות, לאחר פעולה אורולוגית, זיהומים קודמים עמידים) – להיוועץ בימ"ז.

דלקת אוזן חיצונית | Otitis Externa

באנמדה – בירור סיבת הדלקת, והדרכה למניעה ראשונית.

טיפול הבחירה:

- Ear Drops Desoren (Polymyxin+Neomycin+Dexamethasone) X3drps.X3-4/d שימוש עד חלוף סימפטומים. **ריבוי הפרשות מתווה טיפול מקומי במי חמצן 3%**
- Ear Drops Ciprofloxacin X3drps.X2/d שימוש עד חלוף סימפטומים.

טיפול סיסטמי:

לשיקול עבור – חולי סוכרת; מדוכאי חיסון; הזדקרות אפרסכת; התפשטות הזיהום **מעבר לתעלה** external otitis) (Necrotizing) Malignant). במקרה של בצקת תעלה **מומלץ להכניס פתיליה.**

- Cefuroxime 15mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d)
- Levofloxacin 10mg/kg/dose X1/d (max 500 mg/d) למשך 7 ימים **(מעל גיל 5 שנים)** **(בגילאי 6 חודשים עד 5 שנים)** המינון הוא 10mg/kg/dose **פעמיים ביום.**

דלקת אוזן תיכונה | Acute Otitis Media

בתינוקות מעל גיל 6 חודשים, אם המחלה לא קשה או חוזרת ניתן להשהות את הטיפול Abx 24-72 שעות ולטפל סימפטומטית בלבד, תוך מעקב הולם.

(!) **ילד עד גיל 2 חודשים עם AOM – הפניה למיון.**

(!) **מומלץ להתחיל לטפל אם - בלט ניכר/ חום > 39º / אי שקט ניכר/ מום בפנים/ AOM דו"צ**

טיפול הבחירה:

- Amoxicicillin 45mg/kg/dose X2/d (max 2 gr/day)
- Augmentin [600 ES] 45mg/kg/dose X2/d (max 2 gr/d) **(קו 2º)**
- IV/IM Ceftriaxone 50mg/kg/DAY X1/d (max 2 gr/d) למשך 3 ימים **(קו 3º)**

בהתוויות נגד/ אלרגיה:

- Cefuroxime 15mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d)
- Azithromycin 10mg/kg/DAY (max 500 mg X1/d) למשך 3-5 ימים
- Clarithromycin 7.5mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d)
- * כל טיפול PO פרט לאזנלי (>2 שנים – 10 ימים/ 2-5 שנים – 7 ימים/ מגיל 6 – 5-7 ימים)**

לימפאדניטיס צווארית חריפה | Acute Cervical Lymphadenitis

קליניקה קלה – מעקב צמוד אחר בלוטה.

קליניקה בינונית – חום סיסטמי/ רגישות/ חום מקומי בבלוטה – מומלץ טיפול Abx.

קליניקה קשה – מראה חולה/ חום גבוה/ פולקטוואציה/ צלוליטיס/ טריזמוס/ קשיים בבליעה, מומלץ טיפול Abx +ניקוז. **(!)** **בהינתן חום לחשוב האם עונה לקריטריונים של מחלת קוואסקי**

(!) **להעלות ב TB/NTB/Cat Scratch/ DD**

טיפול הבחירה:

- Cephalexin 25mg/kg/dose X3/d (max 4 gr/d) למשך 7 ימים
- Augmentin [400] 45mg/d divided into 2 doses (max 875 mg/dose) למשך 7 ימים

אלרגיה לפניצילין/התוויות נגד/ חשד ל MRSA:

- Clindamycin 10mg/kg/dose X3/d (max 1.8 g/d) למשך 7 ימים

או משלב:

- 1X 2/d (=1 Tab Resprim Forte) SMX-TMP 160/800mg למשך 7 ימים
- בִּסְרִיפּ:** 4mg/kg/dose X2/d(max 20ml X2/d) TMP [40mg/5ml] למשך 7 ימים

וגם

- Clarithromycin 7.5mg/kg/dose X2/d (max 500 mg X2/d) למשך 7 ימים

(!) **כיסוי ל Staph.A של המקרולידים ושל קלינדרמיצין מוגבל בשל עמידויות.**

סינוסיטיס | Sinusitis

אין לשלוח לצילום מערות פנים.

טיפול סימפטומטי: שטיפות אף תכופות עם מי מלח, סטרואידים נזאלים, (בעיקר בנוכחות נזלת אלרגית/ רקע אטופי), דה-קונג'סטנטים כדוגמת Pseudoephedrine.

מתי לשיקול Abx: חום גבוה > 38.0º, תסמינים חמורים מעל 3-4 ימים, מהלך מקדים של URTI במשך מספר ימים ואחריו הופעה שניה של חום (מהלך בִּי-פאזי), היעדר שיפור קליני אחרי טיפול סימפטומטי של 10-7 ימים.

טיפול הבחירה:

- Amoxicicillin 45mg/kg/dose X2/d (max 3 gr/d) למשך 7 ימים
- Augmentin [600 ES] 45mg/kg/dose X2/d (max 3 gr/d) למשך 7 ימים

בהתוויות נגד/ אלרגיה:

- Cefuroxime 15mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d) למשך 7 ימים
- Azithromycin 10mg/kg/dose X1/d (max 500mg/d) למשך 3 ימים
- Doxycycline 2mg/kg/dose X1-2/d (max 200 mg/d) **מעל גיל 8 שנים** למשך 7 ימים

הפניה דחופה למיון: ילד טוקסִי, צלוליטיס, כאב ראש עז, נפיחות במצח, חשד למעורבות ארובת העין (כגון בלט עין, הפרעה בתזוזת גלגל העין, הפרע בראייה), סימנים מיניגיאליים.

זיהומי עור | Skin Infections

אין לקחת תרבית שטחית עורית מפצעים פתוחים.

עור אטופי / פטרת בין אצבעות מהווה Port of entry של חיידקים עוריים. (בעיקר Gram+)

זיהומי עור נקודתיים (כולל Impetigo):

- Mupirocin oint. / Fusidic acid cream/ Gentatrim oint. X2/d למשך 7-14 ימים
- (בעיקר Impetigo) – המלצה על סיבון הגוף בסבון אנטיספטי באירועים חוזרים של זיהומי עור, (במקרה של סיבון הגוף בסבון אנטיספטי

במקרה של התפשטות מהירה של הנגעים, השנות הנגעים, הדבקה חוזרת בתוך המשפחה ואם יש נגעים בפנים, צלוליטיס/ אריספילאס, **הטיפול הוא סיסטמי:**

- Cephalexin 25mg/kg/dose X3/d (max 3 gr/d) למשך 7 ימים

(!) **בהעדר תגובה לצפלוספורינים לשיקול טיפול המכסה MRSA - Community כגון:**

- Clindamycin 10mg/kg/dose X3/d (max 900 mg/d) למשך 7 ימים
- 1X 2/d (=1 Tab Resprim Forte) SMX-TMP 160/800mg למשך 7 ימים
- בִּסְרִיפּ:** 4mg/kg/dose X2/d (max 20ml X2/d) TMP [40mg/5ml] למשך 7 ימים **אם מעל גיל 8 אפשר גם:**
- Doxycycline 2mg/kg/dose X2/d (max 200 mg/d) למשך 7 ימים

בהתוויות נגד/ אלרגיה:

ניתן להשתמש בתכשירים במוצעים מעלה ל MRSA

טיפול פרופילקטי לאירועים חוזרים (מעל 3-4 אירועים בשנה) - בייעוץ ימ"ז

(!) **Paronychia – שכיח בילדים הכוססים ציפורניים/ מוצצים אצבע,** הטיפול כולל חיסוי, **ניקוז מוגבל** אם התפתחה מורסה, קומפרסים חמים, משחה אנטיביוטית מקומית (המוזכרת מעלה) ± ICHTHAMMOL בהעדר שיפור לשיקול כיסוי Abx פומי

הפניה דחופה למיון לשיקול אם: מחלה סיסטמית קשה / כאב לא פרופורציונלי והתפשטות מהירה (חשד ל Nec.Fas), כשלון טיפולי PO אחרי 48 שעות / קושי בנטילת טיפול PO.

נשיכות בעלי חיים | Animal Bites

יש לשטוף את הפצע במים וסבון אנטי בקטריאלי.

אם יש להתייעץ עם לשכת הבריאות המחוזית לגבי חיסון כללבת **(בייחוד חיות בר)** יש **יש חשד למעורבות גידים/עצמות/ מפרקים** – ייעוץ אורתופדי והדמיה בהתאם.

אין לסגור ראשונית, פרט לנשיכות בפנים (עד 24 שעות' מהנשיכה)/ בכדי לשמור על פונקציונליות.

(!) **חיסון טטנוס (אם עברו 5 שנים מהמנה האחרונה)**

טיפול Abx מניעתי (לפני התפתחות הזיהום) מומלץ ל: מדוכאי חיסון; אספלניה; מחלת כבד מתקדמת; בצקת של האיזור הננשך; מעורבות פנים/יד/ סחוס (אוזן, אף וכו'); נשיכה עמוקה. כ 5% מנשיכות כלב מדדהמות, לעומת 50% מנשיכות חתול. **נשיכות בידיים נחשבות High risk (!)** **נשיכות בני אדם – לבדוק HIV+ HBV**

טיפול הבחירה:

- Augmentin [400] 20mg/kg/dose X2/d (max 875 mg/dose) למשך 5 ימים

בהתוויות נגד/ אלרגיה לפניצילין משלב:

- 1X 2/d (=1 Tab Resprim Forte) SMX-TMP 160/800mg למשך 5 ימים
- בִּסְרִיפּ:** 4mg/kg/dose X2/d (max 20ml X2/d) TMP [40mg/5ml]

וגם

- Clindamycin 10mg/kg/dose X3/d (max 900 mg/d) למשך 5 ימים

גסטרואנטריטיס | Gastroenteritis

שלשול **מעל 2 שבועות / במטטיל דורש** בירור מקיף **(כולל צואה לפרזיטים + חיידקים).**

רוב המוחלט של המקרים מאטיולוגיה ויראלית, לכן אינם דורשים טיפול Abx. **מומלץ להתחיל**

טיפול Abx במצבים בהם: הוכחה בבדיקת צואה/ חשד קליני גבוה ל Shigella (שלשול דמי/ עם ריר / מלווה בחום גבוה).

טיפול הבחירה:

- ההידרציה פומית .ORS, לשיקול IV.
- Azithromycin 10mg/kg/dose X1/d (max 500 mg/d) למשך 3 ימים.
- לעיתים ניתן להחליף ל **קו 2º:**
- X1/d (max 2gr/d) IM/IV Ceftriaxone 50mg/kg/dose למשך 5 ימים

(!) **להימנע אנטי-מוטיליים -(Imodium).**

(!) **זיהום מ Giardia – Metronidazole 15mg/kg/DAY divided into 3 doses/d**

למשך 5-7 ימים

זיהום מ Salmonella לא דורש טיפול ואף יכול להאררך את תקופת הנשאות. **(!)** **טיפול ינתן לילדים מתחת לגיל 3 חודשים ומדוכאי חיסון/ אספלניה/ IBD תחת טיפול אימונוסופרסיבי.** Azithromycin הוכח כטיפול יעיל ל Campylobacter המקצר את משך המחלה ומפחית הפצה סביבתית אם ניתן בתחילת המחלה.

כללית

הנהלה רפואית מחוז מרכז

דלקת גרון/ לוע הנגרמת ע"י סטרפטוקוק | Gas Pharyngitis /Tonsilitis

שכיח בגילאי 15-5 שנים. נדיר בילדים ≥ 3 שנים. לעיתים מסתמן גם בכאבי בטן חזקים (מיוחס ללימפאדניטיס מזנטרית). בדיקת הבחירה- **לקיחת משטח גרון.** אין צורך במשטח חוזר בגמר הטיפול. כאשר יש חום גבוה והילד סובל, ניתן לקחת תרבית ולהתחיל Abx, להפסיק בקבלת תרבית שלילית, אחרת- לקחת תרבית ולהמתין לתשובה.

(!) **משטח מהיר – חיובי = התחלת טיפול, שלילי = יש לקחת משטח רגיל**

(!) **התחלת טיפול תוך 9 ימים.**

לפי CENTOR טיפול הבחירה (מגיל 3 ומעלה):

- > 27 ק"ג ← Pen Rafa VK 250mg X2/d למשך 10 ימים
- ≤ 27 ק"ג ← Pen Rafa VK 500mg X2/d למשך 10 ימים
- 1 gr/d) (max 1 gr/d) Amoxicillin 50mg/kg/DAY divided into 1-2 doses/d למשך 10 ימים
- > 27 ק"ג ← IM Benzanthine Penicillin G 600,000 IU מנה חד פעמית
- ≤ 27 ק"ג ← IM Benzanthine Penicillin G 1,200,000 IU מנה חד פעמית

(!) **IM באישור ימ"ז**

בהתוויות נגד/רגישות לפניצילין:

- Cephalexin 20mg/kg/dose X2 (max 1 gr/day) למשך 10 ימים
- Azithromycin 12mg/kg/dose (max 500 mg/d) למשך 5 ימים
- Clindamycin 7mg/kg/dose X3/d (max 900 mg/d) למשך 10 ימים

במקרה של הישנות בודדת בסמיכות לאירוע קודם, יש לטפל באותה Abx כמו באירוע הראשון **(!)** **נשאות GAS בלוע –** אין המלצה לטפל, המלצה טיפולית רק אם עדות להדבקות צולבות "פינג-פונג" במשפחה / מקרה של Rheumatic Fever

דלקת ריאות | Pneumonia

האבחנה היא קלינית. צילום חזה אופציונלי.

אלא אם: אבחנה לא חד-משמעית/ ↓SpO₂/דיספניה משמעותית/ אין תגובה לטיפול או החמרה אחר 48-72 שעות' מתחילת Abx/ חשד נוזל פלאוראלי/ פנאומוטורקס/ פנאומוניטיס משאפיה. חשד קליני גבוה למחלה חיידקית (±מעבדה) מצדיק טיפול Abx כנגד *Strep.P* (הכי נפוץ). לרוב משך הטיפול המומלץ 5 ימים, ניתן להרחיב 10-7 ימים בהתאם למחלה וגורמי סיכון של הילד). **(!)** **בילדים עם חסר חיסוני או מחלות ריאה גנטיות כמו C.F- ייעוץ ימ"ז.**

טיפול הבחירה:

- Amoxicicillin 80-90/kg/DAY divided into 2-3 doses (max 1 gr/dose) למשך 5-7 ימים

בחדש ל- Atypical Pneumonia:

- Azithromycin 10mg/kg/DAY X1/d (max 500 mg/dose/d) למשך 3 ימים
- Clarithromycin 7.5mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d) למשך 7 ימים
- Roxithromycin (tab) 2.5-4 mg/kg X2/d (max 300 mg/d) למשך 7 ימים

אם מעל גיל 8 אפשר גם:

- Doxycycline 2mg/kg/dose X1-2/d (max 200 mg/d) למשך 7 ימים

אלרגיה/התוויות נגד:

- טיפול ב CLARITHRO / AZITHRO במינונים המצוינים מעלה
- Clindamycin 10mg/kg/dose X3/d (max 900 mg/d) למשך 7 ימים
- Cefuroxime 15mg/kg/dose X2/d (max 1 gr/d) למשך 7 ימים **(קו 2º)**
- IV/IM Ceftriaxone 50mg/kg/dose X1/d (max 2 gr/d) למשך 5 ימים **(קו 2º/דלקת**

ריאות חמורה

- Augmentin [600 ES] 90 mg/kg/dose X2/d (max 2 gr/dose) למשך 7 ימים **(קו 2º)**
- Augmentin [400] 45-60 mg/kg/dose X2/d (max 875 mg/dose) למשך 7 ימים **(קו 2º)**

שעלת | Pertusis

במידה ויש חשד סביר לשעלת (קליניקה/אנמנזה) מומלץ לתת טיפול אמפירי ללא המתנה לתוצאות מעבדה. מומלץ לתת את הטיפול בשלבי המחלה המדבקים ביותר – **תוך 3 שבועות מהופעת השיעול, (!)** **RULID לא נחשב טיפול אמפירי טוב לשעלת.**

טיפול הבחירה:

- 1st day) (max 500 mg) Azithromycin **10mg/kg** (2-5th day) (max 250 mg) X1/d Azithromycin **5mg/kg** למשך 5 ימים סה"כ

(!) **בתינוקות עד 6 חודשים –** הטיפול ב־ Azithromycin במ